Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 7 : SHS



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 7 pages numérotées de 1 à 7 et comporte et comporte 1 QROC et 1 commentaire de texte .
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Mot de votre RM :

Coucou mes stars !! J'espère que ce **premier tuto** s'est bien passé pour vous ! Le sujet n'était pas simple, *je le reconnais*, donc pas de panique si vous avez l'impression d'avoir flop. Je suis extrêmement fier de vous pour avoir eu le courage d'affronter l'exercice du commentaire en SHS, c'est un **énorme pas en avant** que vous avez fait. Votre audace, votre rigeur et votre persévérance m'époustouflent, m'enchantent et me comblent de bonheur *(et oui on est pas en SHS pour rien)*(20AuBacDeFrançais).
Plus sérieusement, vous allez avoir le temps de revoir les cours convoqués dans ce sujet, alors pas de stress si vous aviez l'impression de ne **rien savoir** ou que votre note n'est pas à la hauteur de vos attentes ! Votre marge de progression est déjà **énorme** en seulement 1 mois, imaginez seulement ce que vous pouvez faire avec le temps qui vous reste !
Je ne vais pas m'éterniser sur ce mot *qui n'a déjà que trop duré*, lisez bien attentivement cette correction car cela va vous permettre de comprendre ce qui est attendu de vous en épreuve (et on l'a préparée avec amour). Et restez à l'affut, vos **corrections personnalisées** arrivent prochainement !
P.S. : on vous propose un "propos introductif" qui justifie le plan utilisé et explique le raisonnement, n'hésitez pas à nous faire un retour pour nous dire si vous avez trouvé ça utile !

QROC

Comment s'est opérée l'institutionnalisation de la bioéthique au XXème siècle en Amérique du Nord et en France ? (10 lignes)

Correction de la QROC

La bioéthique s'institutionnalise en Amérique du Nord dès les années 1970, portée par des centres universitaires et des revues scientifiques. Elle naît d'une critique sociétale de l'éthique médicale professionnelle et s'affirme comme champ pluridisciplinaire, ouvert à la société. En France, au contraire, le mouvement est plus tardif et d'abord impulsé par les médecins, autour de débats sensibles comme l'avortement (1975, Simone Veil) ou la première FIV (1982, naissance d'Amandine). Ces questionnements aboutissent à la création du Comité Consultatif National d'Éthique en 1983, marquant l'ancrage officiel de la bioéthique dans les institutions françaises.

Commentaire de texte

Organisations complexes conçues afin de répondre aux besoins multiples générés dans et par nos sociétés, les hôpitaux, entreprises sociales inventives s'il en est, sont le théâtre de pouvoirs et d'intérêts qui ne se démentent guère dans le temps. Au-delà des contraintes politiques qui pèsent de plus en plus lourd sur leur organisation, ces entreprises présentent les aspects d'institutions totales avec leurs propres normes, leurs acteurs, leurs rôles, leurs statuts et leurs hiérarchies. Parmi ces acteurs, les médecins dont le savoir, le pouvoir, l'autorité et l'autonomie balisent les voies par lesquelles une profession obtient et maintient le contrôle de son expertise. Cette expertise, contestée en permanence et tenue de se partager, fait l'objet de négociations sans fin entre des groupes sociaux hétérogènes. Les relations interprofessionnelles entre les médecins et les autres travailleurs de la santé peuvent relever explicitement d'une compétition entre professions et/ou métiers pour l'autorité et l'autonomie, mais aussi rendre compte de systèmes d'alliances plus subtils entre ces différents groupes sociaux, patients inclus. [...]

En trente ans, aucune autre organisation sociale n'a sans doute davantage changé que celle de la santé. L'adoption rapide de nouvelles technologies médicales, l'accroissement de la spécialisation des soins et de leur fragmentation, l'escalade des dépenses de services médicaux, la place des patients dans l'exercice de soins : le système de santé a subi, en peu de temps, des changements considérables.

Carricaburu, D. et Ménoret, M. (2004). Conclusion. *Sociologie de la santé : Institutions, professions, maladies* (p. 199-200). Armand Colin

Consigne : À l'aide du texte et de vos connaissances, montrez que des besoins nouveaux, au sein de la société, sont à l'origine de changements dans le système de santé. Comment les hôpitaux en tant qu'"entreprises sociales" sont-ils organisés ? Comment fonctionne leur gouvernance, à la fois politique, marchande et administrative ?

Propos introductif

Le texte se structure en deux parties, mais la consigne propose un plan en trois parties. Il ne faudra donc pas hésiter à se référer à une analyse non-linéaire pour le commentaire. Il apparait que les questions autour de l'hôpital sont prépondérantes dans le texte, faisant manifestement appel aux connaissances développées dans le cours n°2 intitulé «Évolutions des systèmes de santé, acteurs et relations de soin». Toutefois, le texte propose une lecture plus transervsale avec une réflexion sur les revendications sociales, qu'il ne faudra pas hésiter à mentionner du point de vue de la bioéthique. Le texte nous invite d'abord à traiter des contraintes, nouvelles et actuelles, qui pèsent sur le système de santé. Notre propos devra ensuite se centrer sur les aspects organisationnels, notamment hiérarchiques, de l'hôpital pour expliquer en quoi ces contraintes sont le symptôme de tensions historiques au sein de l'institution hospitalière, qui ne font que s'accentuer avec le défi des nouvelles coopérations interprofessionnelles. Enfin, nous devrons considérer que les discordances au sein de l'hôpital s'inscrivent dans une dynamique plus générale de partage de la gouvernance du système de santé. L'hôpital y occupe alors une place priviliégiée en matérialisant les enjeux, les désaccords et les acteurs de cette gouvernance.

Correction du commentaire

Issu de Sociologie de la santé : Institutions, professions, maladies, ce texte de MM. Carricaburu et Ménoret présente une nature à la fois historique et sociologique, puisqu'il traite de l'évolution de l'institution hôpital, des rapports entre ses acteurs, et de la gouvernance de celle-ci. La période traitée pour décrire cette évolution s'étend de la fin du XXe siècle à 2004, sur environ trente ans, dans un contexte d'innovation scientifique, de restructuration de l'hôpital et de son administration, ainsi que de revendications sociales.

Quels sont les enjeux de la gestion de l'"entreprise sociale" qu'est l'hôpital pour répondre à nos « besoins multiples » et nouveaux ? Selon les auteurs, les hôpitaux sont le lieu d'une lutte d'intérêts généralisée, entre les nombreux acteurs de l'institution, pouvant affecter les relations et coopérations interprofessionnelles, et semblant largement dues au changement rapide de fonctionnement de cette « entreprise sociale ».

L'hôpital est d'abord la cible de besoins nouveaux, à la fois amenés par et participant aux changements qui touchent cette institution.

En effet, « aucune autre organisation sociale n'a sans doute davantage changé que celle de la santé » (lignes 13-14) dernièrement, et ce, car des nécessités sociales et sociétales se font de plus en plus présentes. Le vieillissement de la population, qui vit plus longtemps mais souvent en mauvaise santé, et est de plus en plus touchée par des maladies chroniques, demande un grand nombre d'intervenants différents, pour dispenser des soins coordonnés et complets.

Des revendications sociales directement liées à l'exercice du soin, et de la médecine en particulier, se font aussi entendre. Suite au mouvement bioéthique apparu aux États-Unis puis en France, les patients expriment le besoin d'une prise en charge individualisée, complète et concertée. C'est une nouvelle façon d'envisager autant la médecine que le malade, car on revendique « la place des patients dans l'exercice de soins » (ligne 16), en tant que partie prenante des décisions, et non plus sous le joug du paternalisme médical. Ce paternalisme médical structure les relations patients-médecin avant la naissance du mouvement bioéthique, en conférant aux médecins détenteurs des savoirs toute l'autorité et la légitimité des décisions de santé relatives aux patients. Les demandes d'une médecine plus juste et plus respectueuse de l'autonomie du patient se heurtent au manque de moyens, de possibilités, et de temps de l'institution hôpital et des médecins, qui voient leur « expertise contestée en permanence » (ligne 8).

En outre, des nécessités économiques sont parfois directement liées aux revendications sociales. La couverture sociale des Français est de plus en plus importante, permettant un accès quasi universel aux soins, et stimulant ainsi la consommation de soins, notamment à l'hôpital, ce qui se traduit par une « escalade des dépenses de services médicaux » (ligne 15).

Il y a donc une recherche d'une meilleure rentabilité par les acteurs de la gouvernance de l'hôpital, qui vient contredire le besoin d'une médecine plus humaine et individualisée, pour laquelle il faut du temps et des moyens. On sectorise et on spécialise au contraire pour gagner en efficacité, ce qui participe à la « fragmentation » (ligne 15) des soins, et donc à une coordination plus difficile encore de la prise en charge, car le patient passe d'un professionnel à l'autre sans que ceux-ci communiquent forcément (suffisamment). Cette « spécialisation des soins » (ligne 15) est néanmoins essentielle, car « l'adoption rapide de nouvelles technologies » (ligne 14) nécessite des connaissances pointues et précises sur des sujets particuliers, qui balisent très finement le champ d'action des différents professionnels de santé. Tous ces besoins amènent et participent au changement de l'hôpital.

« L'entreprise sociale » qu'est l'hôpital, « inventive » (ligne 2) car se renouvelant sans cesse, poursuit une évolution qui s'est opérée dès la fin du XIXe siècle.

C'est la naissance d'une « machine à traiter les malades », selon l'expression de Michel Foucault. L'acte hospitalier se médicalise, car l'hôpital devient laïc, et est investi par la médecine. Celle-ci est désormais une « profession » (ligne 7), c'est-à-dire une forme d'organisation du

travail médical caractérisée par un statut juridique et des structures représentatives internes de la profession qui défendent son statut, son prestige, ses privilèges, et son « autonomie » (ligne 7), notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et de leur tutelle.

Pourtant, au même moment, l'hôpital, pour peu de temps réservé à « l'expertise » (ligne 8) des médecins, est très vite investi par une administration de fonctionnaires, gestionnaires, et payeurs, avec lesquels les médecins doivent cohabiter. Cela est en partie lié au développement d'une bureaucratie, suite à l'individualisation des patients, et à l'intervention de plus en plus importante de l'État. L'hôpital se mue en un lieu où s'exerce une médecine complexe et pluriprofessionnelle.

Les hôpitaux prennent donc « les aspects d'institutions totales, avec leurs propres normes, leurs acteurs, leurs rôles, leurs statuts, et leurs hiérarchies » (lignes 5-6), dans le sens où ils sont le rassemblement d'une multitude de professionnels différents, ayant chacun leurs normes (au sens de façons de faire) liées à leur profession, et créant un ensemble de « normes » (ligne 6) qui se complètent pour former les règles de l'institution qu'ils se partagent et forment. Ils ont autrement dit chacun leur domaine d'expertise et peuvent avoir des désaccords interprofessionnels, mais ils demeurent les membres d'une institution commune, qui les unit par cela.

L' « aspect[s] d'institution[s] totale[s] » (ligne 5) se résume assez bien dans le terme d'« entreprise sociale » (ligne 2), puisqu'elle allie des métiers de soins, de santé (branche santé/sociale : médecins, infirmiers, aides-soignants), à des métiers de technique, de gestion, d'administration, et d'économie (techniciens, gestionnaires, cadres, évaluateurs, direction).

Cette irruption de nouveaux professionnels, et la nécessité de collaborer pour œuvrer pour le bien-être des patients entraînent des tensions internes, lors des coopérations interprofessionnelles.

En effet, les professions de santé deviennent mouvantes : celles considérées "établies" ne sont ni homogènes ni figées, et peuvent se découvrir des concurrents ou alliés dans des professions "émergentes". La division du travail de soin entre personnel médical et paramédical prend une nouvelle forme, avec de nouvelles responsabilités pour les paramédicaux, qui sont de plus en plus nombreux, et un transfert de compétences qui s'ouvre vers de nouvelles professions (par exemple chez les infirmiers en pratique avancée, les IPA). Il y a une diminution du périmètre d'intervention de chacun des corps professionnels, qui doivent s'adapter aux besoins de santé non figés, et être en interactions les uns avec les autres.

L'accès aux professions est lui très divers (formations différentes, voire nouvelles), et les médecins se sentent parfois lésés, en perte d'autonomie ou d'autorité face à leurs « concurrents », eux qui doivent se faire à l'idée que leur « savoir » ne justifie pas un « pouvoir » (ligne 6) démesuré, à la fois sur le patient (avec un détachement du paternalisme), et sur leurs collaborateurs. L'expertise est désormais « tenue de se partager » (ligne 8), et les professions qui rejoignent le domaine de la santé prennent exemple sur la médecine, qui a « balis[é] les voies par lesquelles une profession obtient et maintient le contrôle de son expertise » (lignes 7-8). Les relations semblent donc plus s'orienter vers une « compétition entre professions et / ou métiers pour l'autorité et l'autonomie », ce qui paraît difficilement conciliable avec une prise en charge coordonnée et correcte des patients. Les « systèmes d'alliances plus subtiles entre ces différents groupes sociaux, patients inclus » (ligne 12), peuvent se retrouver chez des professionnels de domaines d'exercices proches (aides-soignants et infirmiers), ou ayant suivi des formations similaires (médecins, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes et psychomotriciens, etc.). Les associations de patients et les familles, venues du milieu profane, gravitent également dans cette « organisation sociale » (ligne 13) unique, hautement professionnalisée, où différents horizons professionnels et personnes sont rassemblés et poursuivent leurs objectifs respectifs.

Se soulèvent alors des problèmes de communication, de reconnaissance des rôles, de formation et de charge de travail, qui peuvent interférer avec une prise en charge optimale du patient.

De son côté s'ajoute l'administration, qui vient souvent contredire les directives des

professionnels de santé, et dont l'avis compte au moins autant, si ce n'est plus.

L'hôpital est non seulement le lieu de coopérations interprofessionnelles entre soignants, mais également entre les acteurs de sa gouvernance, à la fois administrative, politique, et marchande.

Il est en cela source de conflits « de pouvoir et d'intérêts » (ligne 3) redoutables, car différentes logiques se heurtent entre elles, toutes justifiées ou justifiables. La logique professionnelle, ayant pour but le soin, se confronte notamment à la logique technocratique des gestionnaires (payeurs, évaluateurs, fonctionnaires…) ayant un but de rentabilité. Deux « hiérarchies » (ligne 6) coexistent et s'affrontent parfois au sein de l'institution, car la direction de l'hôpital est administrative, gérée par des fonctionnaires, et son fonctionnement est le fruit du travail des professionnels de santé. Seulement, l'administration s'immisce souvent dans ce fonctionnement même, puisqu'elle est responsable de la gestion des budgets, de la validation des commandes, présente en début et en bout de chaîne de tout ce qui tourne autour de l'acte médical, dans le matériel, les locaux, la gestion du personnel (cadres de santé pour les infirmiers et aides-soignants).

L'administration n'est par ailleurs pas seule responsable, puisque celle-ci rend des comptes aux mondes politique et marchand, devant assurer à la fois satisfaction et rentabilité, critères parfois contradictoires. Le monde marchand, représenté par les sociétés pharmaceutiques, très puissantes, les assurances et groupes financiers impliqués dans l'offre de soin, affirme la supériorité de la logique marchande : le but est de faire du profit. Le monde politique, composé quant à lui d'élus, de représentants légitimes de groupes constitués, revendique la primauté de la logique démocratique, c'est-à-dire ce que veut le peuple et qui est dans son intérêt. Les « contraintes politiques qui pèsent » (lignes 3 - 4) sur cette organisation sont donc lourdes, et influencées par de nombreux facteurs, entre autres économiques.

D'où le développement, en 2003, de la T2A (Tarification à l'activité), qui rebat les cartes du fonctionnement hospitalier. En effet, il ne s'agit plus de soigner à tout prix mais de voir le plus de malades possibles : on économise le temps pour gagner de l'argent, puisque le budget des différents services, et donc de l'hôpital, dépend du nombre de patients consultés. Les logiques gestionnaire et marchande se retrouvent : il s'agit d'être efficace. On retrouve aussi, plus que jamais, l'expression du philosophe Michel Foucault de « machine à traiter les malades ».

D'un point de vue politique, la gestion de l'hôpital relève de la confiance envers les services publics : il y a nécessité d'éviter les scandales, d'autant plus que ceux-ci se sont faits nombreux à la fin du XXème siècle (sang contaminé, vache folle…). On crée donc des agences, indépendantes, qui répondant directement aux scandales ou organisent la santé en France, donnent les directives. La Haute Autorité de Santé (HAS) note par exemple la qualité des soins dans les hôpitaux, en leur attribuant un label, mais fournit également les protocoles de soin à suivre aux médecins. Il s'agit donc pour les médecins de maintenir ou créer des « systèmes d'alliance » (ligne 13) durables pour conserver leur statut, leur liberté d'exercice et leur autonomie, tout en composant avec les nouveaux acteurs, à la fois de santé et de l'administration, qui prennent place parmi eux.

En conclusion, l'évolution de l'institution qu'est l'hôpital public est constante, et s'est accélérée depuis la fin du XXème siècle, connaissant une métamorphose du point de vue de son administration, de sa gouvernance, et de ses acteurs de soin. Cela est en grande partie dû aux besoins nouveaux, sociétaux, sociaux, économiques, et aux innovations en santé apparus ces dernières décennies. Si la régulation de la médecine est en partie externe, au niveau de l'hôpital, elle est également et surtout organisée par la profession, avec l'Ordre des médecins, créé en 1945, qui veille au respect de la déontologie, lutte contre le charlatanisme (historiquement surtout, mais encore actuellement) et encadre les professionnels en décidant de leur droit d'exercer ou non.

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM SHS GT 25-26), Lilou BIGNAMI (DFGSMa2), Fatima OUTISKET (DFGSO2, RM SHS L.AS 25-26), Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM SHS EB 25-26)

Relecteurs :

Ava SILVAGNI (DFGSM2), Clara SCHWANDER (DFGSMa2), Lisa RAACHINI (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Souad BENABDI (DFGSM2) et Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team SHesS**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Myrtille SIBOURD (DFGSM2, RM SHS GT 25-26), Benjamin PLASSART (DFGSM2, RM SHS EB 25-26)

Prenez votre copie en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre copie sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP